

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 06

LA LOI-CADRE 06-22



06 16 03 08 31

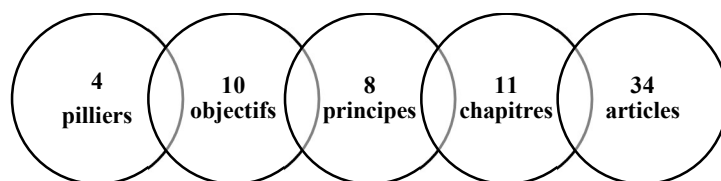


slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

INTRODUCTION

Le projet de loi-cadre n°06-22 relatif au **système national de santé**, adopté récemment en **Conseil des ministres**, a vocation à réformer le secteur selon une approche **pluridimensionnelle**. Articulé autour de **quatre piliers : bonne gouvernance, valorisation des ressources humaines, mise à niveau de l'offre sanitaire et digitalisation**, ce texte dresse un plan d'ensemble pour une réforme en profondeur devant notamment permettre de mener à bien le chantier de la généralisation de la protection sociale.



	Numéro	Dahir N°	Date de promulgation	N° du BO	Date de publication	Lieu	N° chapitre/ article
Réforme du système de santé	06.22	1.22.77	09.12.2022	Ar : 7151 Fr : 7178	Ar : 12.12.2022 Fr : 16.03.2023	Rabat	11 chapitres 34 articles

La promotion du secteur de la santé, son développement et le rehaussement de ses performances est une responsabilité partagée entre **l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics** d'une part, et le **secteur privé, la société civile, les organisations professionnelles et la population**.

La réforme en profondeur du système national de santé est devenue une nécessité impérieuse et une priorité nationale parmi les priorités de la politique générale de l'Etat tendant à **valoriser le capital humain** et à **prendre soin de la santé des citoyens** comme condition essentielle et fondamentale pour la réussite du modèle de développement escompté.

En exécution de ces Hautes directives royales et considérant que le **droit à la santé** constitue un **droit humain fondamental**.

En vertu des dispositions de la Constitution, notamment son **article 31** qui dispose que **l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès** des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir, particulièrement du droit **aux soins de santé**.

En application des dispositions du deuxième alinéa de **l'article 71 de la Constitution**, la présente loi-cadre vise à **mettre en place un cadre juridique des objectifs fondamentaux** de la réforme du système national de santé et sa **restructuration** selon une approche participative fondée sur **l'adhésion collective et responsable de l'État et de l'ensemble des acteurs** concernés.

Cette approche est axée principalement sur la mobilisation et la gestion participative, sur le partenariat solidaire entre les différents intervenants, en vue de la restructuration du système selon une vision prospective à long terme basée sur l'adoption d'une politique de santé préventive efficiente et une offre de soins équitable et équilibrée.

Afin de garantir les conditions nécessaires à cette réforme, il a été procédé à :

- ☞ Une **révision globale de la gouvernance du système de santé** dans toutes ses composantes, à travers la mise en **valeur des ressources humaines** travaillant dans le secteur de la santé, **l'amélioration des systèmes de formation sanitaire**, l'attraction des **compétences médicales exerçant à l'étranger**
- ☞ La création d'un **système d'information sanitaire national** intégré, et d'un **système d'accréditation des établissements** de santé
- ☞ La création d'organismes spécialisés de gestion et de gouvernance en l'occurrence, la **Haute Autorité de Santé** chargée des missions d'encadrement technique du chantier de l'assurance maladie obligatoire de base et les **groupements sanitaires territoriaux** chargés de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la santé au niveau régional, outre la création **d'un établissement public des médicaments et des produits de santé** et d'un autre **établissement public pour l'approvisionnement en sang et ses dérivés**.

Cadre référence

1. Directives royales pour s'engager dans une refonte du système National
2. La constitution 2011 : la santé est un droit humain fondamental,
3. Convention internationale (OMD/ODD)
4. Loi 09-21 relative à la protection sociale
5. Programme de l'action gouvernementale
6. Recommandations du nouveau modèle de développement

Raisons de la refonte

1. Succession d'un certain nombre de réformes sans apporter de réel changement dans le secteur
2. Pénurie chronique et carence aiguë de ressources humaines
3. Iniquité dans la répartition de l'offre de soins et non-respect des normes de la carte sanitaire dans les créations des établissements
4. Faible gouvernance du système de santé
5. Absence de complémentarité entre les secteurs public et privé

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

L'objectif générale / 04 actions de l'état

L'action de l'état dans le domaine de la santé tend à œuvrer pour réaliser :

1. La sécurité sanitaire
2. Protéger la santé de la population,
3. Prémunir les individus contre les maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie
4. Leur garantir la vie dans un environnement sain.

Les 10 objectifs spécifiques de l'Etat

1. Faciliter l'accès de la population aux prestations de santé et améliorer la qualité de ces prestations
2. Garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national
3. Asseoir la territorialisation de l'offre de soins dans le secteur public et améliorer sa gouvernance à travers la création de groupements sanitaires territoriaux
4. Garantir la souveraineté en matière de médicaments ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits de santé
5. Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé
6. Réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé
7. Renforcer l'encadrement sanitaire en vue d'atteindre les normes de l'OMS dans ce domaine 1.6
-> **4.51 pour 1000**
8. Valoriser et mettre à niveau les ressources humaines travaillant dans le domaine de la santé à travers la mise en place d'une fonction sanitaire qui prend en considération les spécificités des fonctions et des professions du secteur.
9. Mettre en œuvre les mécanismes de partenariat, de coopération et de complémentarité entre les secteurs public et privé.
10. Encourager la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine de la santé.

Les 08 principes de SNS

1. L'égalité de l'offre de soins et aux prestations de santé
2. La Bonne gouvernance
3. La continuité des prestations de santé
4. La mutualisation des moyens
5. L'équité et l'équilibre dans la répartition spatiale des ressources, des structures et des prestations de santé sur l'ensemble du territoire national.
6. L'adoption de l'approche genre dans l'élaborations des politiques des programmes et des stratégies de santé
7. La gestion basée sur les résultats et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des

comptes

8. La mobilisation de l'ensemble des citoyennes et citoyens, des institutions, des organismes relevant des secteurs public et privé ainsi que des associations de la société civile et leur implication dans l'exécution de la politique de l'Etat relative à la prévention des épidémies, des maladies et des autres risques sanitaires, et celle relative aux programmes visant l'amélioration de la situation sanitaire de la population et la disponibilité des soins de santé de base

Les 4 piliers de loi Cadre 06-22

1. Instauration d'une nouvelle gouvernance du système de santé
2. Valorisation des ressources humaines
3. Mise à niveau de l'offre des soins
4. Mise en place d'un système d'information national et intégré

Chapitre II : les Droits et Devoir de la population.

Droits de la population

1. Santé publique
2. Santé de l'individu
3. Politique de sang
4. Politique pharmaceutique

Santé de l'individu

Mesures nécessaires que l'Etat doit prendre pour mettre en œuvre ses engagements dans le domaine de la santé :

1. L'information de la population sur les risques sanitaires et sur les comportements et les mesures de précaution à adopter pour les prévenir
2. La protection de la santé et l'accès aux soins de santé appropriés disponibles
3. La garantie de la protection de l'intégrité physique et morale des personnes
4. Le respect du droit du patient à l'information relative à sa maladie et la modalité de sa prise en charge
5. La lutte contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation qu'une personne peut subir en raison de sa maladie, de son handicap ou de ses caractéristiques génétiques

MEP d'une politique pharmaceutique

L'Etat veille à la mise en place d'une politique pharmaceutique visant :

1. La garantie de la disponibilité du médicament
2. L'amélioration de sa qualité
3. La réduction de son prix.
4. La disponibilité des produits et des dispositifs médicaux nécessaires à la protection de la santé

L'Etat œuvre particulièrement :

1. Renforcement du développement d'une industrie pharmaceutique locale et à l'encouragement du développement des médicaments génériques
2. La fixation des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation, de distribution et de dispensation des médicaments
3. La fixation des conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non-médicamenteux et des dispositifs médicaux
4. Encourager et développer la recherche scientifique dans le domaine du médicament et des sciences médicales et sanitaires

MEP d'une politique de sang

Œuvrer pour assurer la disponibilité du sang et de ses dérivés :

1. À travers tous les moyens possibles, en veillant à garantir la sécurité et la qualité de ces produits

Santé Publique

L'Etat œuvre à la prise des mesures nécessaires a :

1. La prévention des risques menaçant la santé : Dans le cadre d'une politique commune, complémentaire et intégrée entre tous les secteurs et en coordination avec tous acteurs concernés
2. Chaque fois que la vie et la sécurité des individus se trouvent menacées du fait de la propagation de maladies contagieuses ou épidémies : Prendre les mesures d'urgence nécessaires à la protection des individus contre ces maladies et à la limitation de leur

propagation et ce, en vue de parer aux risques pouvant en résulter

Devoirs de la population :

1. Respect des règles de santé publique : toute personne est tenue d'observer (Chacun a l'obligation de respecter les règles et mesures de protection générale de la santé établies par les services publics de santé.)
2. Obligation en cas de maladie transmissible : En cas de maladie transmissible (Si une personne contracte une maladie transmissible constituant un danger pour la communauté, des mesures spécifiques doivent être prises.)
3. Intervention des services publics : Soins et mesures prophylactiques (Les services publics doivent soumettre la personne malade à des soins appropriés et prendre des mesures prophylactiques (préventives) pour empêcher la propagation de la maladie.) et (Mesures pour les contacts : Des mesures peuvent également être prises à l'égard des personnes en contact avec la personne malade pour limiter les risques de transmission.)
4. Conformité législative : Conformément aux dispositions législatives (Toutes ces actions doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.)

Chapitre III : L'OFFRE DE SOINS

Les compositions de l'offre de soins

L'offre de soins comporte,

1. Les ressources humaines
2. L'ensemble de l'infrastructure sanitaire relevant des secteurs publics et privé
3. Toutes autres installations de santé fixes ou mobile
4. Les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé.

Répartition de l'offre de soins

- 🏠 L'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer une répartition : **équilibrée et équitable** sur l'ensemble du territoire national En fonction des particularités et des besoins de chaque région.
- 🏠 Le secteur public et le secteur privé (à but lucratif ou non) sont organisés de manière synergique afin de répondre avec efficacité aux besoins de santé par une offre de soins et des prestations : **complémentaires, intégrées et cohérents**

Organisation de l'offre de soins

L'offre de soins est organisée au niveau de chaque région conformément à la carte sanitaire régionale de l'offre de soins dans le respect du parcours des soins commence par le passage par :

- 🏠 Les établissements de soins de santé de base (secteur public)
- 🏠 Un médecin généraliste (secteur privé)

Amélioration et Développement de l'offre de soins

- 🏠 En vue de l'amélioration de l'offre de soins **l'Etat doit procéder** en particulier la mise à niveau continue des infrastructures de santé
- 🏠 En vue de développement de l'offre de soins l'état prend les mesures nécessaires Pour attirer :
 - ❖ Les compétences des marocains résidents à l'étranger et les compétences étrangères
 - ❖ Les investissements étrangers De manière à permettre le transfert et el partage des expertises et el rehaussement de la qualité des prestations de santé

CHAPITRE IV : LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Système nationale de santé

Ensemble des institutions des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, aux niveaux national et régional et qui sont organisés pour la réalisation des objectifs de l'état dans le domaine de la santé

Les établissements de santé

Les divers établissements privés ou publiques, quel que soit le régime juridique, organisés dans le but de contribuer à l'offre de soins

Les missions des établissements de santé

Les établissements de santé (chacun selon son objet) assurent :

- 👤 Des prestations de prévention
- 👤 Des prestations de diagnostic
- 👤 Des prestations de soins
- 👤 Des prestations de réadaptation

Qu'elles nécessitent ou non une hospitalisation au sein de l'établissement.

L'organisation et la gestion des établissements

Chaque établissement de santé est organisé pour :

- 👤 Assurer aux patients les conditions de sécurité sanitaires optimales possibles
- 👤 Accueillir les patients des conditions adaptées à leur état de santé y compris en cas d'urgence
- 👤 Les diriger, le cas échéant, vers l'établissement de santé approprié

L'organisation et la gestion des établissements de santé relevant du secteur public ou privé sont soumis aux dispositions relatives à l'exercice de la médecine et des autres professions de santé.

L'organisation et la gestion de ces établissements doivent obéir aux principes, **normes et règles** :

- 👤 Les droits fondamentaux des personnes ;
- 👤 Les normes de sécurité des usagers ;
- 👤 Les normes de sécurité des personnes qui y travaillent ;
- 👤 Les normes de sécurité des installations et des équipements ;
- 👤 Les règles de déontologie applicables à chaque profession ;
- 👤 Les normes et standards de qualité ;
- 👤 Les règles d'hygiène et de salubrité ;
- 👤 Les règles de bonne pratique clinique.

Missions des établissements de santé/ actions de partenariat

Outre les missions citées ci-avant, les établissements de santé contribuent aux actions suivantes

Formation dans le domaine de la santé :

Les établissements de santé participent à la formation initiale et continue des professionnels de la santé.

Recherche scientifique :

Ils contribuent à la recherche scientifique dans le domaine de la santé

Développement de partenariats :

Ils développent des relations de partenariat avec des associations professionnelles.

Actions de partenariat :

Les établissements de santé peuvent collaborer, le cas échéant, avec

-  Institutions de formation
-  Organisations professionnelles
-  Sociétés savantes concernées

Ils peuvent également collaborer avec :

-  Organisations professionnelles
-  Associations
-  Toute autre organisation de la société civile

Objectifs et contributions

Ils sont encouragés à contribuer à la réalisation des objectifs du Système National de Santé (S.N.S), notamment en ce qui concerne les actions relatives à l'information, éducation, et communication (IEC).

CHAPITRE V : LA CARTE SANITAIRE ET LES CARTES RÉGIONALES DE L'OFFRE DE SOINS

La carte sanitaire nationale

Établie par : L'administration centrale

Et précise : des orientations générales pour la répartition de l'offre de soins

Base d'analyse :

- ☁ Offre de soins existante.
- ☁ Données géo-démographiques
- ☁ Données épidémiologiques.

La carte sanitaire régionale

Établie par : Groupement sanitaire territorial

Durée : établie pour une période déterminée

Contenu :

- ☁ Inventaire global de l'offre de soins dans les secteurs public et privé.
- ☁ Mesures pour le secteur public visant à :
 - ❖ Satisfaire les besoins de la population en soins et prestations de santé.
 - ❖ Prévisions relatives aux ressources humaines, établissements de santé, lits, places, spécialités, installations fixes et mobiles, équipements lourds, et répartition spatiale.
 - ❖ Assurer l'harmonie et l'équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles.
 - ❖ Réduire les disparités intrarégionales dans l'offre de soins.

Objectifs :

1. Réponse convenable aux besoins de la population en matière de soins et de services de santé au niveau régional, en arrêtant les prévisions attendues surtout en matière des Ressources humaines et des établissements de santé et les lits et les lieux, et les spécialités et les installations fixes et mobiles, les équipements lourds et sa répartition territoriale.
2. Assurer la cohérence et l'équité dans la répartition des Ressources humaines et financières au niveau régional.

3. Veille à réduire les inégalités intra régionales dans le cadre de l'offre de soins.
4. La carte sanitaire régionale de l'offre de soins sera établie, pour une période donnée. Il pourra être révisé en cas de changement des orientations générales citées dans CSR.

CHAPITRES VI : PARTENARIAT ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVÉ

- ☞ Partenariat public-privé dans le secteur de la santé repose sur la complémentarité et la mutualisation des ressources, et que l'État joue un rôle clé dans l'instauration de ce partenariat en tenant compte des spécificités du secteur.
- ☞ L'État est responsable de la mise en place de mécanismes pour coordonner les soins de santé entre les secteurs public et privé, conformément à l'article 21.
- ☞ Selon l'article 22, les établissements de santé publics peuvent solliciter les professionnels du secteur privé pour accomplir des missions spécifiques, dans les conditions et modalités définies par des règlements.
- ☞ **En conclusion** : la coopération entre le secteur public et privé dans le domaine de la santé, en soulignant le rôle de l'État dans l'établissement et la coordination de ce partenariat, ainsi que la possibilité pour les établissements publics de recourir aux ressources du secteur privé.

CHAPITRES VII : LES RESSOURCES HUMAINES / LA FORMATION / LA RECHERCHE ET L'INNOVATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

- 1) **Création d'une fonction sanitaire**, statut de la fonction sanitaire fixé par la loi 09,22 relatif.
Objectif : Instaurer une fonction sanitaire qui vise la valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public.

Déterminer en particulier :

- ☞ Les garanties fondamentales qui sont accordées aux R.H
- ☞ Leurs droits et leur devoir
- ☞ Le régime de leur rémunération de base, en partie, sur la corrélation entre la rémunération et l'accomplissement des actes professionnels

2) MEP d'un système de formation :

- ☁ L'état veille à la mise en place d'un système de formation dans les professions de santé.
- ☁ L'état œuvre à assurer la qualité des formations dispensées et à rehausser leur rendement.

3) Caractéristiques du système de formation :

Le système de formation vise à répondre au besoin du pays en cadres à travers :

- ☁ Une formation de base développée
- ☁ Une formation professionnelle dans les divers domaines de la santé fondée sur les normes de :
 - ❖ Qualité
 - ❖ D'efficience
 - ❖ Professionnalisme
 - ❖ Compétence.

- ☁ La mise à niveau continue des cadres de santé de toutes catégories.

4) Le rôle Les établissements de formation :

Les établissements de formation dans le domaine de santé relevant du secteur public et privé sont chargés des missions :

- ☁ Formation de base
- ☁ De spécialisée dans les diverses disciplines
- ☁ De formation continue

5) La recherche :

L'Etat et les autres organismes publics et privés œuvrent à la prise de toutes les mesures nécessaires **à l'encouragement** des acteurs concernés **à développer** des projets de recherche **À** réaliser des programmes scientifiques spécialisés **dans** le domaine de santé **revêtant** un caractère de priorité nationale

CHAPITRES VIII : DIGITALISATION DE SYSTÈME DE SANTÉ

1) Système d'information intégré :

Création d'un système d'information sanitaire national intégré :

- 🔗 En vue d'assurer le suivi et l'évaluation des performances du système de santé
- 🔗 Dans lequel sont collectés et traités toutes les données relatives aux établissements de santé :
Privé et publics à leurs activités et ressources.

2) Dossier médical partagé :

- 🔗 Création d'un système informatique intégré dénommé dossier médical partagé au sein du système d'information sanitaire national intégré permet :
- 🔗 L'identification, suivi et l'évaluation du parcours de soins de chaque patient

CHAPITRE IX : SYSTÈME D'ACCREDITATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Il est institué un système d'accréditation des établissements de santé **en vue d'assurer** l'amélioration continue de la **qualité** et de la **sécurité** des soins.

Vise à :

- 🔗 Porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé
Le cas échéant
- 🔗 Des prestations fournies par un ou plusieurs services relevant de ces établissements Et ce sur la base
- 🔗 D'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux établis par la "Haute Autorité de Santé"

CHAPITRE X : ORGANES DE GESTION ET DE GOUVERNANCE

1) Gestion :

En application du principe de gestion axée sur les résultats l'état veille à la création de deux établissements publics :

☞ L'un chargé des médicaments et produits de santé

☞ L'autre chargé du sang et ses dérivés

2) Instances de gouvernance :

ORGANES DE GESTION ET DE GOUVERNANCE

HAS : Haute autorité de santé

Elle est chargée de :

☞ L'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base. (Remplace ANAM)

☞ l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé.

☞ donner son avis sur les politiques publiques dans le domaine de la santé

GST : Groupements sanitaires territoriaux

Ils sont chargés de :

La mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la santé.

Chaque groupement comprend tous les établissements de santé relevant du secteur public situés dans son ressort territorial

Etablissement chargé des médicaments

Etablissement chargé du sang et dérivés

3) Gouvernance :

En application du principe de bonne gouvernance l'état veille à la création d'une haute autorité chargée :

☞ De l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base,

☞ De l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé

☞ De donner son avis sur les politiques publiques dans le domaine de la santé

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FINALES

- ☞ La présente loi-cadre sera mise en œuvre en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour son application.
- ☞ La loi-cadre no 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins est abrogée.